

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE BIENESTAR SOCIAL DE KEYES (SWBS)

Eje IV: Funcionamiento Social y Adaptación • Modelo Multidimensional de Ajuste Comunitario

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Bienestar Social de Keyes (SWBS).
Nombre Original	Social Well-Being Scale (SWBS; Keyes, 1998).
Autores Originales	Corey L. M. Keyes, Ph.D. (Emory University, Department of Sociology).
Adaptación Hispana	Amalio Blanco y Darío Díaz (2005, 2007); Universidad Autónoma de Madrid, España.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Ajuste Social. Calidad percibida de la relación del individuo con la sociedad.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme multidimensional (25 reactivos en versión adaptada).
Formato de Respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (≥ 15 años) en contextos comunitarios, laborales y de salud mental.
Tiempo de Administración	8 a 10 minutos de administración autónoma.
Régimen de Licencia	Uso público abierto para fines de investigación y evaluación clínica sin ánimo de lucro.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO DE BIENESTAR SOCIAL DE KEYES

La **SWBS** fue desarrollada por Corey Keyes (1998) con el fin de superar el reduccionismo individualista de los modelos tradicionales de salud mental y bienestar subjetivo:

- La Sociedad como Escenario Vital:** La salud psíquica completa no se agota en el bienestar psicológico personal (Ryff) o hedónico (Diener); exige que la persona se sienta integrada, productiva y valorada en su comunidad y comprenda las dinámicas de su entorno social.
- Superación de la Anomia Durkheimiana:** Operacionaliza las dimensiones positivas del vínculo social frente a los estados de anomia, extrañamiento, cinismo social y alienación colectiva.
- Aplicabilidad Clínica y Psicosocial:** Esencial para evaluar el impacto del estigma, el aislamiento crónico en trastornos mentales graves y la eficacia de intervenciones comunitarias y psicosociales.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL (5 DIMENSIONES / 25 ÍTEMS)

Dimensión del Bienestar	Nº Ítems	Definición Operativa del Constructo en la SWBS
1. Integración Social	5 ítems	Sentimiento de pertenencia a la comunidad, cercanía y apoyo mutuo percibido.
2. Aceptación Social	5 ítems	Confianza en las personas, tolerancia a la diversidad y visión positiva del ser humano.
3. Contribución Social	5 ítems	Creencia de ser un miembro útil, valioso y con algo que aportar a la sociedad.
4. Actualización Social	5 ítems	Confianza en el progreso, evolución, futuro y potencial benéfico de la sociedad.
5. Coherencia Social	5 ítems	Percepción de inteligibilidad, orden lógico y previsibilidad del mundo colectivo.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La validación española de Blanco y Díaz (2005; $N = 432$ participantes comunitarios) confirma la solidez psicométrica del modelo pentafactorial:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.83 - 0.88	Alta coherencia factorial global; factores específicos oscilan entre 0.69 y 0.83.
Estructura Factorial	CFI = 0.94; RMSEA = 0.05	Confirmación empírica del modelo pentafactorial correlacionado de Keyes.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.80 - 0.85	Adecuada estabilidad temporal a 4 semanas en población general.
Validez Convergente	$r = 0.52 - 0.64$	Correlación positiva robusta con la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff.
Validez Discriminante	$r = -0.48$ (Anomia)	Correlación inversa con escalas de anomia de Srole y desamparo social.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

• **Inversión de Ítems Negativos:** Se invierte la puntuación de los reactivos redactados en sentido de desconfianza o rechazo social (ítem invertido = 6 - valor original: 1 a 5, 2 a 4, 3 a 3, 4 a 2, 5 a 1). • **Puntuación por Dimensiones (5 Factores):** Suma de los 5 reactivos correspondientes a cada factor (rango de 5 a 25 puntos por dimensión). • **Puntuación Global de Bienestar Social SWBS:** Suma de las 5 dimensiones puntuadas:

$$\text{Puntuación Total SWBS} = \sum_{j=1}^5 \text{Dimensión}_j \quad (\text{Rango: 25 a 125 puntos})$$

• **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor bienestar social percibido y menor vivencia de alienación o rechazo comunitario.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

Estratificación	Rango Total	Media Dimensión	Significación Psicosocial y Nivel de Integración
Alto Bienestar	100 a 125 pts	4.00 a 5.00	Conexión social óptima; alto capital social, confianza y civismo comunitario.
Bienestar Medio	75 a 99 pts	3.00 a 3.99	Integración adaptativa típica; percepción normal de la vida colectiva.
Ajuste Bajo	50 a 74 pts	2.00 a 2.99	Sentimientos de marginación, desconfianza hacia las instituciones e impotencia.
Anomia / Alienación	< 50 pts	< 2.00	Aislamiento social severo; cinismo institucional extremo; anomia invalidante.

CRITERIO DE ALERTA DE EXCLUSIÓN SOCIAL (TOTAL < 65 / CONTRIBUCIÓN < 10):

Puntuaciones totales inferiores a **65 puntos**, o caídas aisladas en Contribución Social (< 10), predicen con alta sensibilidad riesgo de abandono escolar, cese de búsqueda de empleo y retraimiento depresivo crónico en jóvenes y adultos en desempleo prolongado.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y SALUD MENTAL PÚBLICA

PROTOCOLO DE REINSERCIÓN SOCIAL CON SWBS:

- **Paso 1 (Línea Base en Programas de Salud Mental Comunitaria):** Aplicar en usuarios derivados a centros de rehabilitación psicosocial o programas de apoyo al empleo.
- **Paso 2 (Análisis del Perfil Factorial):** - *Baja Integración / Aceptación* (< 12): Indicar talleres de habilidades sociales, asertividad comunitaria y grupos de apoyo mutuo. - *Baja Contribución Social* (< 10): Priorizar voluntariado tutelado o actividades con impacto social observable para restaurar autoeficacia cívica. - *Baja Coherencia Social* (< 10): Trabajar psicoeducación sobre recursos cívicos y desmitificación de barreras institucionales.
- **Paso 3 (Reevaluación a los 6 Meses):** Considerar objetivo terapéutico superado con una ganancia de ≥ 15 puntos totales.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: REHABILITACIÓN TRAS AISLAMIENTO POR AGORAFOBIA Y DESEMPLEO

Identificación: Varón de 31 años, en paro desde hace 3 años tras superar un trastorno de angustia severo. Aunque no padece ataques de pánico activos, manifiesta desconexión radical de la sociedad: "Siento que el mundo va por un lado y yo por otro; no pinto nada en esta sociedad ni le importo a nadie".

Evaluación Inicial SWBS (25 reactivos): • **Puntuación Total SWBS = 48 / 125 puntos (Rango de Anomia y Alienación Social).** • *Desglose Factorial:* Integración Social = 8/25; Aceptación Social = 9/25; Contribución Social = 6/25; Actualización Social = 12/25; Coherencia Social = 13/25.

Intervención Psicosocial: Programa de Integración Comunitaria: participación en huerto urbano vecinal dos mañanas a la semana, sesiones de orientación sociolaboral y rol-playing para trámites administrativos.

Reevaluación a los 6 Meses: La puntuación SWBS ascendió a **86 / 125 puntos (Bienestar Social Medio / Adaptativo)**. Contribución Social subió a 17/25 e Integración a 18/25. El usuario se vinculó a una asociación vecinal y consiguió un contrato de formación laboral.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTA DE MARGINACIÓN CRÓNICA:

Una Contribución Social persistentemente nula (≤ 6) es un predictor crítico de claudicación en la búsqueda de empleo y desarrollo de ideación suicida pasiva.

SESGO CULTURAL O POLÍTICO:

Puntajes bajos en Coherencia o Actualización en crisis económicas pueden reflejar descontento político objetivo, no patología mental del evaluado.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. *Social Psychology Quarterly*, 61(2), 121-140.
2. Blanco, A., & Díaz, D. (2005). El bienestar social: su concepto y medición. *Psicothema*, 17(4), 582-589.
3. Keyes, C. L. M., & Shapiro, A. D. (2004). Social well-being in the United States: A descriptive epidemiology. In O. G. Brim et al. (Eds.), *How healthy are we?* (pp. 350-372). University of Chicago Press.
4. Blanco, A., & Díaz, D. (2007). El rostro anómico del bienestar social. *Psicothema*, 19(3), 411-415.